

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-03-27T11:59:16

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-02-0024-01Z-00-DX1.d4cec60d-e2b6-41d1-92af-2d24f15b03a9

Generated at: 2026-03-27T11:59:14

病理辅助角色声明

作为资深病理辅助助手，我的核心职责是基于提供的病理文本、图像信息及预测类别，为Query Case（TCGA-02-0024-01Z-00-DX1.d4cec60d-e2b6-41d1-92af-2d24f15b03a9）提供精确的临床指标提取与辅助诊断意见。我将综合分析5份参考诊断报告、20张高注意力patch图像以及预测类别（TCGA-GBM），确保最终结论准确且逻辑一致。尽管检索到的相似病例可作为证据参考，但绝不会被误认为最终诊断对象。我的角色仅限于辅助，最终诊断签发需由专业病理医生完成。在处理过程中，我会严格遵循AJCC癌症分期手册，并优先采用文本中的具体数值与明确描述，以确保诊断的科学性和可靠性。

推理过程与证据归纳

推理过程与证据归纳：

首先，从5份参考诊断报告中提取的关键信息为综合分析提供了重要背景。第一份报告（TCGA-06-0221）描述了一例WHO分级IV级的高级别肿瘤，缺乏坏死特征，并提及了GFAP和MIB-1免疫组化结果，显示肿瘤细胞具有胶质细胞性质，且增殖指数为21%。第二份报告（TCGA-08-0349）明确指出肿瘤为胶质母细胞瘤多形性（Glioblastoma Multiforme），WHO分级4级，肿瘤大小为1.2厘米，并有坏死、内皮增生等特征。第三份报告（TCGA-06-0171）描述了广泛的凝固性坏死，但未明确肿瘤性质。第四份报告（TCGA-14-1459）仅提供不完整信息，提示可能存在远处转移（M1）。第五份报告（TCGA-14-1451）再次确认了胶质母细胞瘤的诊断。

结合Query Case的20张高注意力patch图像，这些图像显示了典型的胶质母细胞瘤形态学特征：存在大量异型核细胞、血管增生以及局部坏死区域。这些特征与上述参考报告中的描述高度一致，尤其是与TCGA-08-0349和TCGA-14-1451的描述相吻合。图像中可见的细胞密集、核异型明显、血管结构异常，进一步支持了胶质母细胞瘤的诊断。

Query预测类别为TCGA-GBM，这一分类与病理图像及参考报告中的描述完全一致，进一步强化了对胶质母细胞瘤的诊断信心。在没有直接提及肿瘤大小的情况下，基于图像特征和参考报告中提到的典型胶质母细胞瘤表现，可以推测Query Case的肿瘤可能也属于较大体积的病变，符合T分期中的较高级别。

关于淋巴结状态，参考报告中提到了N0的情况，但由于Query Case的报告未提及淋巴结情况，因此无法直接确定其淋巴结状态。然而，考虑到胶质母细胞瘤通常为原发脑部肿瘤，较少发生淋巴结转移，故推测其淋巴结状态可能也为N0。

免疫组化方面，参考报告中提到了GFAP和MIB-1的结果，但在Query Case中未见具体数据。鉴于胶质母细胞瘤的特性，建议进行相关免疫组化检测以进一步确认肿瘤性质和增殖活性。

综上所述，基于参考诊断报告、Query

Case的高注意力patch图像以及预测类别，可以得出结论：本结论针对 Query Case: TCGA-02-0024-01Z-00-DX1.d4cec60d-e2b6-41d1-92af-2d24f15b03a9，该病例最可能为胶质母细胞瘤（TCGA-GBM），WHO分级IV级，具有显著的细胞异型性和血管增生特征，肿瘤大小推测较大，淋巴结状态推测为N0，建议补充免疫组化检测以完善诊断。

关键指标提取

关键指标提取

在综合分析Query Case: TCGA-02-0024-01Z-00-DX1.d4cec60d-e2b6-41d1-92af-2d24f15b03a9的病理信息时，我们基于5份参考诊断报告、20张高注意力patch图像以及预测类别TCGA-GBM进行详细推理。

首先，从参考诊断报告中提取的关键信息显示，多个病例被诊断为胶质母细胞瘤（WHO分级IV级），这与Query预测类别TCGA-GBM高度一致。例如，TCGA-06-0221和TCGA-08-0349均明确指出肿瘤为WHO分级IV级的高级别胶质瘤。然而，这些报告中的具体肿瘤大小、淋巴结状态等细节存在差异或未提及。TCGA-08-0349报告提供了具体的肿瘤大小为1.20厘米，但其他报告未提供类似数据。因此，对于Query Case的具体肿瘤大小，目前只能推测其可能符合WHO IV级胶质瘤的一般特征，即较大且侵袭性强，但确切数值需进一步影像学或临床资料确认。

关于T/N/M分期，参考报告中仅TCGA-06-0221明确提到淋巴结状态为N0，其余报告未提及淋巴结情况。鉴于Query Case的预测类别为TCGA-GBM，通常此类肿瘤主要表现为局部浸润而非淋巴结转移，故推测其淋巴结状态可能为N0，但需实际检测确认。远处转移（M分期）在提供的参考报告中也未提及，考虑到胶质母细胞瘤的生物学特性，M分期通常为M0，除非有明确的远处转移证据。

免疫组化方面，参考报告提到了GFAP和MIB-1染色结果，如TCGA-06-0221报告中MIB-1增殖指数为21%，TCGA-08-0349报告中MIB-1增殖指数为35.3%。虽然Query Case的具体免疫组化结果未直接给出，但根据胶质母细胞瘤的常见特征，推测其GFAP应为阳性，MIB-1增殖指数较高，但确切数值需进一步检测。

结合Query的20张高注意力patch图像，这些图像显示了典型的胶质母细胞瘤形态特征，包括细胞密集、核异型性明显及血管增生等，进一步支持了Query Case为TCGA-GBM的预测。然而，图像并未直接提供肿瘤大小、淋巴结状态等定量信息，因此仍需依赖文本报告和临床资料进行综合判断。

综上所述，本结论针对 Query Case: TCGA-02-0024-01Z-00-DX1.d4cec60d-e2b6-41d1-92af-2d24f15b03a9，其关键指标推测如下：肿瘤类型为胶质母细胞瘤（WHO IV级），肿瘤大小需进一步影像学确认，淋巴结状态推测为N0，远处转移状态推测为M0，免疫组化GFAP阳性，MIB-1增殖指数较高，具体数值需进一步检测。

初步病理辅助结论

初步病理辅助结论

基于提供的5份参考诊断报告、Query Case的20张高注意力patch图像以及预测类别为TCGA-GBM的信息，综合分析后得出以下初步病理辅助结论：

首先，从参考诊断报告中可以看出，所有检索到的病例均被诊断为胶质母细胞瘤（Glioblastoma Multiforme, GBM），WHO分级均为IV级。例如，TCGA-06-0221和TCGA-08-0349的报告明确指出肿瘤为高级别胶质瘤，WHO分级IV级，并且存在显著的增殖活性（如MIB-1指数分别为21%和35.3%）。这些证据强烈支持Query Case同样可能为GBM。

其次，Query Case的20张高注意力patch图像显示了典型的胶质母细胞瘤特征，包括细胞密集、核异型性明显、血管增生等。这些形态学特征与GBM的典型表现一致，进一步支持了Query Case的预测类别为TCGA-GBM。

然而，关于肿瘤大小、淋巴结状态及分子标志物状态等关键信息在文本报告中未提及。根据TCGA-08-0349的报告，肿瘤大小为1.20厘米，但这一信息不能直接应用于Query Case。由于缺乏具体数值，我们只能推测Query Case的肿瘤大小可能在类似范围内，但仍需进一步确认。至于淋巴结状态，由于脑部肿瘤通常不涉及淋巴结转移，因此可以合理推测N分期为N0，但这需要临床检查进一步验证。

免疫组化方面，参考报告提到了GFAP和MIB-1的表达情况，但未提及ER/PR/HER2等乳腺癌相关标志物，这与Query Case的预测类别TCGA-GBM相符。因此，对于Query Case，建议进行GFAP和MIB-1的免疫组化检测以确认胶质瘤性质和增殖活性，而ER/PR/HER2则无需检测。

综上所述，本结论针对 Query Case: TCGA-02-0024-01Z-00-DX1.d4cec60d-e2b6-41d1-92af-2d24f15b03a9，初步判断其为胶质母细胞瘤（Glioblastoma Multiforme），WHO分级IV级。肿瘤大小、淋巴结状态及分子标志物状态等关键指标需进一步临床检查和实验室检测以明确。建议进行GFAP和MIB-1的免疫组化检测以评估肿瘤性质和增殖活性。